# CUIDADOS COM O PACIENTE CRÍTICO

Apostila em fichas para o técnico de enfermagem no CTI adulto

| Paciente | Sinais | Dispositivos | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Consciência e conforto | Tendências e perfusão | Posição e função | Comunique e anote |

## Avaliar, prevenir, reconhecer e comunicar

O paciente crítico exige atenção contínua às mudanças. Esta apostila reúne cuidados frequentes e sinais de alerta; não substitui prescrição, treinamento, supervisão do enfermeiro ou protocolo do serviço.

Setembro de 2026 • Referências oficiais e diretrizes clínicas ao final

## Como estudar estas fichas

Em cada tema, leia primeiro o motivo clínico e depois a ação prática. Ao chegar ao leito, organize seu raciocínio: o que mudou, quando mudou, qual o risco e quem precisa saber agora?

## Seu papel no cuidado

O técnico participa da observação, execução de cuidados e registro sob supervisão do enfermeiro, seguindo prescrição e protocolos. Diagnóstico, decisões terapêuticas e ajustes complexos pertencem aos profissionais habilitados responsáveis.

## Mapa de prioridades

• Imediato: via aérea/respiração, circulação, consciência e sinais de deterioração.

• Contínuo: medicamentos, dispositivos, diurese, pele, dor, segurança e prevenção de infecção.

• Em toda mudança: confirmar achado, proteger paciente, comunicar, registrar intervenção e resposta.

# 1. Primeira avaliação e prioridades

Paciente crítico pode mudar rapidamente. Compare o estado atual com o anterior e comunique alterações: tendência e contexto são tão importantes quanto um número isolado.

### 01 Recebimento do plantão

POR QUE IMPORTA

Confira identificação, motivo da internação, alergias, metas e restrições, dispositivos, bombas, medicações de alto risco e intercorrências.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Faça conferência à beira-leito conforme rotina e esclareça dúvidas antes de assumir os cuidados.

### 02 Identificação segura

POR QUE IMPORTA

Use pelo menos dois identificadores conforme protocolo. Leito e aparência não substituem identificação.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Antes de medicação, coleta, procedimento, dieta ou transporte, confira pulseira e prescrição.

### 03 Abordagem ABCDE

POR QUE IMPORTA

A: via aérea; B: respiração; C: circulação; D: estado neurológico; E: exposição/pele. É uma estrutura para reconhecer deterioração.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Se houver instabilidade, acione a equipe imediatamente e atue dentro do protocolo e da sua competência.

### 04 Tendências dos sinais vitais

POR QUE IMPORTA

PA, PAM, FC, FR, $SpO_2$ e temperatura precisam ser interpretados com linha de base e condição clínica.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Documente valores e horários, confirme achado inesperado e comunique piora persistente ou súbita.

### 05 Perfusão periférica

POR QUE IMPORTA

Cor, temperatura das extremidades, enchimento capilar, consciência e diurese podem indicar alteração de perfusão.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Observe em conjunto com PA e contexto; não considere PAM isolada suficiente para avaliar o paciente.

### 06 Mudança de consciência

POR QUE IMPORTA

Confusão nova, sonolência excessiva, agitação e menor resposta podem refletir hipóxia, perfusão, glicemia, sedação ou outra causa.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Avalie segurança da via aérea, glicemia conforme protocolo, sinais vitais e avise a equipe.

## 2. Respiração e via aérea

O paciente vem antes do monitor. A oxigenação pode deteriorar mesmo com dispositivos aparentemente conectados.

### 07 Padrão respiratório

POR QUE IMPORTA

Observe FR, profundidade, uso de musculatura acessória, cianose, fala e movimento torácico.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Taquipneia, esforço ou redução da consciência exigem avaliação rápida, mesmo que $SpO_2$ ainda esteja aceitável.

### 08 Oximetria e oxigênio

POR QUE IMPORTA

$SpO_2$ estima saturação; não mede $CO_2$ e pode sofrer interferência por má perfusão ou sensor inadequado.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Compare com sinais clínicos, meta prescrita, dispositivo e posição do sensor.

### 09 Ventilação mecânica

POR QUE IMPORTA

O cuidado inclui via aérea, fixação, circuito, valores medidos, alarmes e condição do paciente.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Não silencie alarme sem avaliar. Confirme tubo e conexões antes e após banho, virada ou transporte.

### 10 Aspiração de via aérea

POR QUE IMPORTA

Indicada por sinais clínicos de secreções; pode provocar dessaturação e alterações hemodinâmicas.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Siga técnica e atribuições institucionais, monitore resposta e registre aspecto de secreção quando pertinente.

### 11 Prevenção de pneumonia associada à VM

POR QUE IMPORTA

Inclui cabeceira quando permitida, higiene oral, cuidado com cuff e avaliação diária da necessidade de ventilação pela equipe.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Confirme cabeceira, realize higiene conforme protocolo e comunique secreção, alteração respiratória ou falha no dispositivo.

### 12 Risco de broncoaspiração

POR QUE IMPORTA

Rebaixamento de consciência, disfagia e dieta enteral podem aumentar risco, mas a avaliação é individual.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Observe tosse, vômito, distensão, posição e alterações respiratórias; siga rotina da dieta e avise intercorrências.

## 3. Circulação, perfusão e terapias

Acompanhe resposta a fluidos, drogas vasoativas e dispositivos invasivos sem improvisar ajustes. Identifique cedo sinais de choque e sangramento.

## 13 Pressão arterial invasiva (PAI)

POR QUE IMPORTA

Cateter arterial permite monitorização contínua; valores dependem de sistema íntegro e nivelamento correto.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Observe curva, fixação, local, sangramento e discrepâncias. Zeragem e manejo conforme protocolo/equipe habilitada.

## 14 Drogas vasoativas em bomba

POR QUE IMPORTA

Noradrenalina e outros agentes alteram circulação; interrupção, erro de concentração e extravasamento podem ser graves.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Confira identificação da linha e bomba, acesso, volume remanescente, meta prescrita e resposta; avise qualquer falha.

## 15 Cateter venoso central (CVC)

POR QUE IMPORTA

Usado para terapias selecionadas; infecção, obstrução, deslocamento e extravasamento são riscos.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Observe curativo, conexões, permeabilidade, dor, hiperemia, secreção e integridade da linha; técnica asséptica.

## 16 Acesso venoso periférico

POR QUE IMPORTA

Pode falhar por infiltração, flebite ou extravasamento, sobretudo em infusões irritantes.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Inspecione local e queixa de dor/ardor; registre e comunique alteração antes de seguir infusão.

## 17 Sangramento

POR QUE IMPORTA

Anticoagulação, procedimentos e coagulopatia alteram risco. Sangramento oculto também é possível.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Observe curativos, drenos, urina, fezes, mucosas, PA e FC; comunique nova perda ou piora.

### 18 Reposição de volume

POR QUE IMPORTA

Entrada de fluidos deve ser cotejada com diurese, edema, perfusão e respiração.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Registre volume infundido corretamente e observe sinais de sobrecarga ou hipoperfusão.

## 4. Rins, metabolismo e nutrição

O registro correto permite reconhecer disfunção e acompanhar tratamento. Um valor deve sempre ser relacionado ao período em que foi medido.

### 19 Balanço hídrico

POR QUE IMPORTA

Soma entradas e saídas no intervalo definido; erros de medida podem comprometer decisões.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Inclua infusões, dietas, lavagens quando previstas, diurese, drenos e outras perdas segundo protocolo.

### 20 Diurese

POR QUE IMPORTA

Queda persistente pode sugerir disfunção renal, hipoperfusão, obstrução do sistema ou outra causa.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Meça por horário, verifique coletor e dobras, compare com período anterior e avise queda inesperada.

### 21 Cateter vesical de demora

POR QUE IMPORTA

Sistema fechado e indicação revisada ajudam a reduzir infecção urinária associada ao cateter.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Mantenha coletor abaixo da bexiga, evite dobras e desconexões, cuide da fixação e registre aspecto/volume.

### 22 Glicemia capilar

POR QUE IMPORTA

Hipoglicemia e hiperglicemia podem alterar consciência e evolução clínica.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Confira horários, protocolo de insulina, dieta e valor inesperado; comunique e aja pelo protocolo de hipoglicemia.

### 23 Eletrólitos

POR QUE IMPORTA

Potássio, sódio, cálcio e magnésio influenciam ritmo cardíaco, músculos e consciência.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Observe resultados comunicados, ECG, sintomas e infusões; eletrólitos concentrados exigem alta vigilância.

### 24 Dieta enteral

POR QUE IMPORTA

A nutrição pode ser por sonda nasogástrica ou nasoenteral, conforme prescrição; deslocamento e intolerância são riscos.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Confirme identificação e posicionamento segundo rotina antes de administrar, cabeceira e sinais de intolerância.

### 25 Náusea, evacuação e abdome

POR QUE IMPORTA

Distensão, vômitos, diarreia e ausência de evacuação podem influenciar dieta, hidratação e risco de aspiração.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Registre frequência, volume/aspecto pertinente e comunique mudança importante.

## 5. Pele, mobilidade e conforto

Imobilidade, umidade, dispositivos e baixa perfusão aumentam risco de lesão. Prevenção é contínua e individualizada.

### 26 Avaliação da pele

POR QUE IMPORTA

Inspecione proeminências ósseas, sacro, calcâneos, occipital e áreas sob dispositivos.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Descreva localização e aspecto de alteração e avise o enfermeiro; não massageie área hiperemiada.

## 27 Mudança de decúbito

POR QUE IMPORTA

Reposicionamento distribui pressão; frequência e técnica dependem de tolerância, dispositivos e plano de cuidado.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Planeje com equipe, proteja linhas/tubo, use recursos de alívio de pressão e reavalie pele e sinais vitais.

## 28 Dispositivos e lesão por pressão

POR QUE IMPORTA

Máscaras, cânulas, fixadores, oxímetros e meias podem comprimir pele.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Verifique pontos de contato e proteção adequada, sem comprometer função do dispositivo.

## 29 Higiene e banho

POR QUE IMPORTA

Além de conforto, é oportunidade de examinar pele, dispositivos e nível de consciência.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Organize materiais, preserve privacidade e temperatura, evite tração e confira tudo ao final.

## 30 Dor

POR QUE IMPORTA

O paciente pode relatar dor mesmo intubado; quando não consegue, escalas comportamentais ajudam.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Aplique escala institucional, observe antes/depois de cuidados e comunique dor não controlada.

## 31 Sono e ambiente

POR QUE IMPORTA

Ruído, luz, dor e procedimentos fragmentam sono, aumentando desconforto.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Agrupe cuidados quando possível, oriente dia/noite e reduza estímulos sem atrasar cuidados necessários.

## 32 Mobilização precoce

POR QUE IMPORTA

Pode reduzir consequências da imobilidade quando planejada para paciente elegível.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Não mobilize sem avaliar estabilidade e apoio. Proteja dispositivos e interrompa se houver intolerância.

# 6. Neurológico, sedação e delirium

Sedação, dor e delirium são dimensões diferentes. Escalas e comunicação ajudam a encontrar mudanças sutis.

## 33 Escala de sedação (RASS)

POR QUE IMPORTA

Expressa nível de agitação/sedação; meta é individualizada e prescrita pela equipe.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Registre valor conforme treinamento e comunique desvio da meta ou mudança súbita.

## 34 Delirium

POR QUE IMPORTA

Alteração aguda e flutuante de atenção e consciência; pode ser hipoativo, sem agitação evidente.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Observe flutuação, sono, orientação e comportamento; informe para avaliação com ferramenta do setor.

## 35 Orientação e comunicação

POR QUE IMPORTA

Fale com o paciente, explique procedimentos e ofereça recursos de comunicação se ele não consegue falar.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Cheque compreensão e necessidades básicas; respeite privacidade e autonomia sempre que possível.

## 36 Convulsão ou déficit focal novo

POR QUE IMPORTA

Movimentos anormais, assimetria, fraqueza ou mudança súbita de pupilas/resposta requerem avaliação imediata.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Proteja contra trauma, marque início e duração, avalie via aérea e acione a equipe; não contenha à força.

### 37 Família e acolhimento

POR QUE IMPORTA

Presença e informação adequada podem apoiar recuperação e reduzir desorientação, conforme políticas do serviço.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Identifique pessoa autorizada, acolha dúvidas e direcione decisões e informações clínicas à equipe responsável.

## 7. Segurança, medicações e procedimentos

No CTI há muitas linhas, bombas e medicamentos de alta vigilância. Rotina padronizada diminui erros.

### 38 Medicamentos de alta vigilância

POR QUE IMPORTA

Insulina, anticoagulantes, opioides, sedativos, vasopressores e eletrólitos concentrados exigem barreiras adicionais.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Aplique dupla checagem onde indicada, confira bomba, via, concentração, paciente e monitorização.

### 39 Compatibilidade e identificação das linhas

POR QUE IMPORTA

Misturar soluções incompatíveis pode precipitar ou reduzir efeito; linha sem etiqueta favorece erros.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Não conecte em via desconhecida; identifique solução, paciente, horário e linha conforme protocolo e consulte farmácia/equipe.

### 40 Higiene das mãos

POR QUE IMPORTA

Medida essencial antes e depois do contato, procedimento, exposição a fluidos e entorno do paciente.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Luvas não substituem higiene das mãos; siga precauções e técnica institucional.

### 41 Precauções e isolamento

POR QUE IMPORTA

Contato, gotículas e aerossóis exigem medidas específicas segundo agente e procedimento.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Confira sinalização, equipamento de proteção, transporte e limpeza de itens compartilhados.

### 42 Prevenção de quedas

POR QUE IMPORTA

Mesmo paciente crítico pode tentar levantar quando melhora, fica confuso ou muda sedação.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Avalie risco conforme protocolo, organize leito e campainha, garanta assistência na mobilização.

### 43 Coletas e resultados críticos

POR QUE IMPORTA

Resultados podem demandar resposta rápida; coleta errada pode levar a tratamento equivocado.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Confirme identificação, recipiente e horário; comunique resultado crítico segundo fluxo e registre comunicação.

### 44 Transporte intra-hospitalar

POR QUE IMPORTA

Movimento e troca de equipamentos aumentam risco de perda de via aérea, infusão e monitorização.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Equipe define plano; confira identificação, dispositivos, oxigênio, bombas, bateria e documentação antes e após.

## 8. Registro e resposta a intercorrências

Anotação objetiva mostra o que foi observado, feito e comunicado. Em deterioração, primeiro proteja o paciente e chame ajuda.

### 45 Anotação de enfermagem

POR QUE IMPORTA

Registre horário, achado mensurável, cuidado realizado, resposta e comunicação relevante, sem julgamento ou cópia automática.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Exemplo: “14h20: $SpO_2$ 88% com esforço respiratório; enfermeira comunicada às 14h22; equipe à beira-leito”.

### 46 Passagem de plantão

POR QUE IMPORTA

Transmita riscos ativos, mudanças, pendências, metas e dispositivos.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Se houver informação contraditória, confira prontuário e paciente com a equipe.

## 47 Deterioração inesperada

POR QUE IMPORTA

Dessaturação, hipotensão, arritmia, sangramento, rebaixamento ou parada exigem resposta coordenada.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Acione ajuda e protocolo local, avalie segurança imediata e informe o que mudou, quando e quais medidas ocorreram.

## 48 Evento adverso ou quase erro

POR QUE IMPORTA

Identificar uma falha antes do dano permite corrigir o processo.

O QUE O TÉCNICO OBSERVA / FAZ

Proteja paciente, avise enfermeiro, registre fatos e siga fluxo de notificação institucional.

# Mapas mentais para revisão prática

Os mapas complementam as fichas e ajudam a revisar o cuidado à beira-leito. Leia o mapa, feche a página e tente explicar os pontos principais. Condutas, frequência dos cuidados e metas devem seguir o protocolo do CTI.

# Mapa 1 - Admissão do paciente na UTI

Organiza identificação, avaliação inicial, segurança, dispositivos, registros e comunicação com a família.




Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 2. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

# Mapa 2 - Checklist de enfermagem no paciente crítico

Síntese das prioridades que precisam ser revisitadas ao longo do turno.




Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 25. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

# Mapa 3 - Cuidados diários essenciais na UTI

Integra higiene, prevenção de infecção, pele, mobilização, dispositivos, conforto e registro.




Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 202. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

# Mapa 4 - Avaliação da dor na UTI

Revisa autorrelato, escalas comportamentais, fatores agravantes e reavaliação após intervenção.




Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 326. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

# Mapa 5 - Delirium na UTI

Ajuda a reconhecer formas hiperativa e hipoativa, fatores de risco e medidas não farmacológicas.




Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 333. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

# Mapa 6 - Banho no leito e higiene do paciente crítico

Apresenta preparação, segurança, privacidade, avaliação da pele e proteção dos dispositivos.




Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 340. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

# Mapa 7 - Higiene oral na UTI

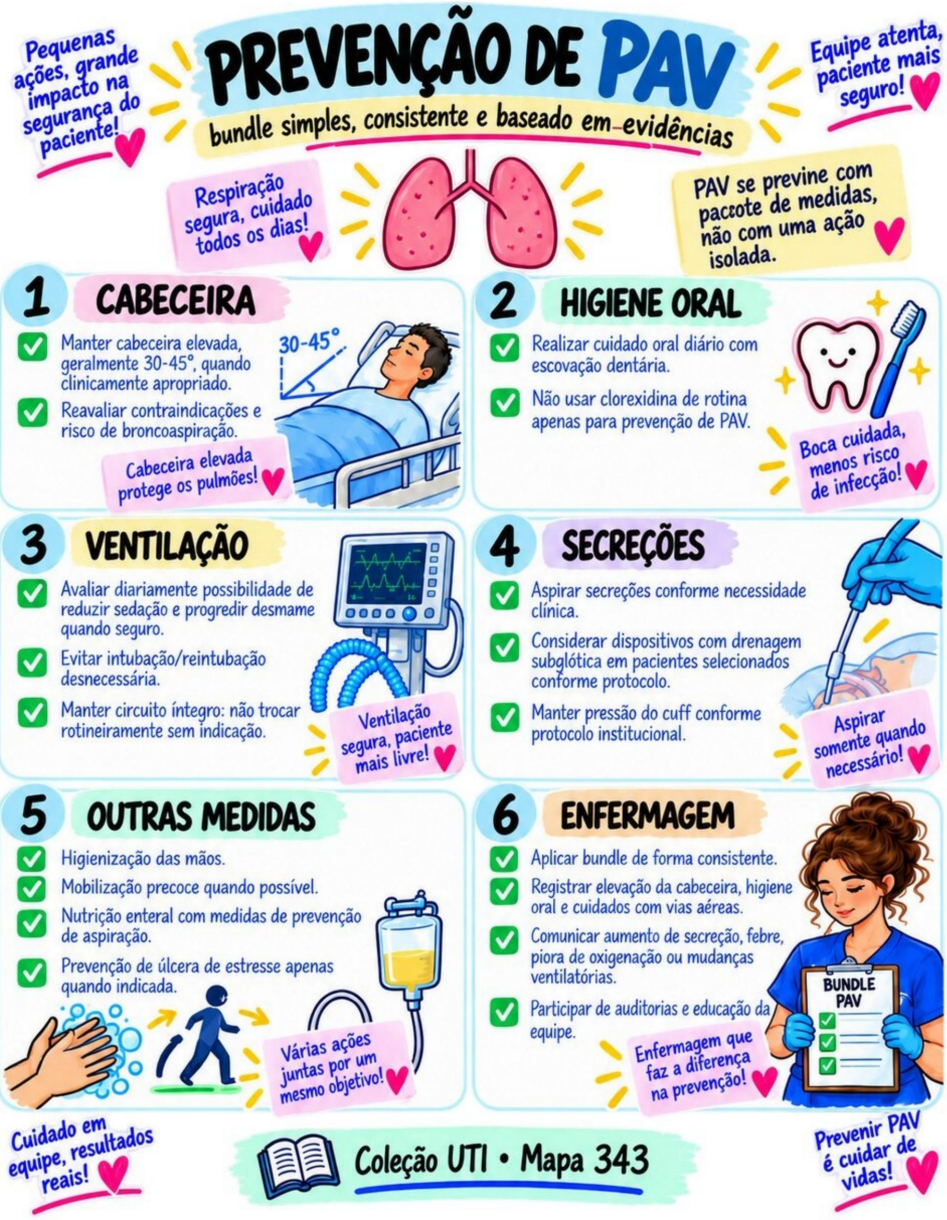
Reforça avaliação da cavidade oral, técnica, frequência prescrita e prevenção de complicações.




Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 343. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

# Mapa 8 - Prevenção de pneumonia associada à ventilação

Resume medidas multiprofissionais, cuidados de enfermagem e sinais de alerta respiratório.




Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 344. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

# Mapa 9 - Mobilização precoce na UTI

Mostra benefícios, critérios de segurança, planejamento e sinais para interromper a atividade.




Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 347. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

# Mapa 10 - Passagem de plantão

Estrutura uma comunicação objetiva sobre riscos, mudanças, dispositivos, metas e pendências.




Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 349. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

# Mapa 11 - Transporte do paciente crítico

Checklist visual de planejamento, monitorização, oxigênio, equipamentos, acessos e comunicação.




Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 350. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

## Situações para treinar o raciocínio

## Durante o banho, a $SpO_2$ cai e o ventilador alarma

Suspenda a movimentação, observe paciente, tubo e circuito sem tração, peça ajuda e siga protocolo. Depois registre o evento e a resposta.

## Diurese caiu nas últimas horas

Confirme volume e período, cheque dobras e posição do coletor, compare sinais de perfusão e balanço; comunique a equipe.

## Paciente antes calmo agora está muito sonolento

Verifique respiração, sinais vitais, glicemia conforme protocolo e infusões; comunique mudança neurológica imediatamente.

## Cateter periférico com dor e edema

Avalie local e infusão, não continue usando acesso suspeito, avise enfermeiro e registre achados.

## Checklist breve de início de plantão

- Identificação, alergias, metas, restrições e riscos.
- Paciente: respiração, perfusão, consciência, dor, pele e conforto.
- Dispositivos: fixação, identificação, integridade, parâmetros e alarmes.
- Bombas, medicações de alto risco, acessos, dieta, diurese e balanço.
- Mudanças importantes, comunicações e registros pendentes.

## Referências

Fontes consultadas em 22/09/2026. Priorize sempre o protocolo atual do CTI e a orientação do preceptor.


ANVISA. Caderno 4: Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/caderno-4-medidas-de-prevencao-de-infeccao-relacionada-a-assistencia-a-saude.pdf

ANVISA. Nota Técnica 05/2023: prevenção de lesão por pressão. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/notas-tecnicas-vigentes/nota-tecnica-gvims-ggtes-anvisa-no-05-2023-praticas-de-seguranca-do-paciente-em-servicos-de-saude-prevencao-de-lesao-por-pressao

ANVISA. Protocolo de prevenção de quedas. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/protocolo-de-prevencao-de-quedas

ANVISA. Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/protocolo-de-seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos

SCCM. ICU Liberation Bundle (A-F) e diretriz PADIS 2025. https://sccm.org/clinical-resources/iculiberation-home/abcdef-bundles

SCCM/ESICM. Surviving Sepsis Campaign, adultos 2026.
https://www.sccm.org/clinical-resources/guidelines/guidelines/surviving-sepsis-campaign-international-guidelines-for-management-of-sepsis-and-septic-shock-2026

COFEN. Registros de Enfermagem no Exercício da Profissão.
https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/Registros-de-Enfermagem-no-Exercicio-da-Profissao.pdf

AARC. Patient-Ventilator Assessment (2024).
https://www.aarc.org/wp-content/uploads/2024/10/patient-ventilator-assessment-aarc-cpg.pdf

ANVISA. Protocolo 2026 para prevenção de ITU associada ao cateter vesical.
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/prevencao-e-controle-de-infeccao-e-resistencia-microbiana/prevencao-das-principais-iras/infeccao-do-trato-urinario/protocolo-3-prevencao-de-itu-final.pdf

COFEN. Resolução nº 736/2024 - Processo de Enfermagem.
https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

SCCM. Atualização focal PADIS 2025.
https://sccm.org/clinical-resources/guidelines/guidelines/focused-update-padis-guideline